

Radar de sinais relevantes para a realidade hospitalar nacional

**Portugal
06/2026**

Versão nº 1 de 13-07-2026

Relatório produzido pela PDH
para a produção de informação relevante na área da
farmacovigilância.

RESUMO

O período de referência (últimos 30 dias) foi marcado por duas conclusões regulamentares europeias com impacto potencial na prática hospitalar: a conclusão do PRAC de que a evidência sobre o potencial risco de perturbações do neurodesenvolvimento em crianças filhas de homens tratados com valproato é inconsistente — com manutenção das medidas de precaução e atualização da informação do produto — e o resumo das recomendações do CHMP de junho de 2026.

A estes desenvolvimentos junta-se um alerta do MHRA sobre angioedema associado a inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA) e um conjunto de publicações e sinais de segurança relevantes, incluindo semaglutida/deficiência de tiamina/encefalopatia de Wernicke, rosuvastatina/rabdomiólise por interação com inibidores do BCRP e hematotoxicidade após terapêutica com CAR-T. O relatório destina-se a farmacêuticos hospitalares em Portugal.

SINAL A — VALPROATO E PERTURBAÇÕES DO NEURODESENVOLVIMENTO EM FILHOS DE HOMENS TRATADOS

Fonte: PRAC 8–11 de junho de 2026 — conclusão de avaliação de sinal de segurança [N43]

EMA — Meeting highlights PRAC 8–11 June 2026: ema.europa.eu

O que aconteceu: Nas meeting highlights do PRAC de 8–11 de junho de 2026, publicadas em 12 de junho de 2026, o comitê concluiu a revisão de um sinal de segurança sobre valproato e substâncias relacionadas. Com base nos novos dados avaliados, o PRAC concluiu que a evidência sobre perturbações do neurodesenvolvimento em crianças filhas de homens tratados com valproato é inconsistente e que o papel causal do valproato é incerto. O comitê recomendou manter as medidas de precaução existentes para doentes do sexo masculino e atualizar a informação do medicamento para refletir os dados mais recentes.

Contexto e motivo: As medidas de precaução existentes tinham sido introduzidas em 2024 para abordar um potencial aumento do risco de perturbações do neurodesenvolvimento em crianças filhas de homens tratados com valproato nos três meses anteriores à concepção.

Medicamentos afetados: Medicamentos contendo valproato e substâncias relacionadas.

Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal: Por se tratar de uma conclusão do PRAC no contexto da EMA, tem relevância regulamentar europeia e deve ser acompanhada em Portugal. A mensagem não deve ser comunicada como confirmação de risco causal: o ponto central é a incerteza da evidência, a manutenção das medidas de precaução existentes para os doentes do sexo masculino abrangidos e a atualização da informação do medicamento.

O que importa rever nos casos locais

- Preparar nota para a Comissão de Farmácia e Terapêutica clarificando que a evidência é inconsistente e que a causalidade é incerta.
- Manter as medidas de precaução existentes para doentes do sexo masculino, conforme informação do medicamento e procedimentos locais.
- Acompanhar a atualização da informação do medicamento e garantir que os prescritores de valproato têm conhecimento da conclusão do PRAC.

Grau de prioridade local: Alta

SINAL B — ANGIOEDEMA ASSOCIADO A INIBIDORES DA ENZIMA DE CONVERSÃO DA ANGIOTENSINA (IECA)

Fonte: MHRA — Drug Safety Update de 17 de junho de 2026, noticiado pelo The Pharmaceutical Journal [N8]

The Pharmaceutical Journal — MHRA drug safety warning, ACE inhibitors: pharmaceutical-journal.com

O que aconteceu: Em Drug Safety Update de 17 de junho de 2026, o MHRA alertou que os IECA devem ser interrompidos imediatamente perante suspeita de angioedema — por exemplo, tumefação da língua, lábios, face ou laringe, ou dor/cólicas gastrointestinais — num doente em tratamento.

Contexto e motivo: O angioedema de início tardio é uma reação adversa pouco frequente ou rara conhecida dos IECA e pode ocorrer em qualquer momento do tratamento, incluindo após semanas a anos de utilização. O MHRA sublinha a distinção entre angioedema mediado por histamina (alérgico) e mediado por bradicinina (não alérgico). Os IECA são uma causa importante do tipo mediado por bradicinina, que habitualmente ocorre sem urticária, tem início mais lento e é improvável que responda ao tratamento padrão da anafilaxia, incluindo adrenalina.

Medicamentos afetados: Inibidores da enzima de conversão da angiotensina (IECA).

Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal: Trata-se de um grupo terapêutico de utilização ampla. O reconhecimento do mecanismo mediado por bradicinina é clinicamente crítico, pois condiciona a interpretação da falta de resposta ao tratamento padrão da anafilaxia. Grupos de maior risco identificados na fonte: idosos, mulheres, fumadores e doentes de etnia negra ou afro-caribenha. Nota: trata-se de um alerta de uma agência do Reino Unido, sem aplicação regulamentar direta confirmada em Portugal.

O que importa rever nos casos locais

- Informar equipas clínicas e de urgência sobre a distinção entre angioedema mediado por bradicinina e por histamina.
- Reforçar a necessidade de suspensão imediata do IECA perante suspeita de angioedema.
- Integrar esta mensagem em ações de formação sobre reconhecimento e notificação de RAM graves.

Grau de prioridade local: Alta

SINAL C — RECOMENDAÇÕES DO CHMP DE JUNHO DE 2026

Fonte: CHMP 22–25 de junho de 2026 — resumo da reunião publicado a 26 de junho de 2026 [N25]

EMA — Meeting highlights CHMP 22–25 June 2026: ema.europa.eu

O que aconteceu: A EMA publicou, em 26 de junho de 2026, o resumo da reunião do CHMP de 22–25 de junho de 2026. O comité recomendou seis novos medicamentos para aprovação e 12 medicamentos para extensão das respetivas indicações terapêuticas.

Contexto e motivo: Trata-se do resumo regular das conclusões do CHMP, com relevância regulamentar e clínica. Este relatório não reproduz a listagem integral dos medicamentos e indicações; a fonte da EMA deve ser consultada para detalhe.

Medicamentos afetados: Medicamentos objeto de recomendações do CHMP na reunião de junho, incluindo os seis novos medicamentos recomendados para aprovação e os 12 medicamentos com recomendação de extensão de indicação.

Impacto potencial para a farmácia hospitalar em Portugal: Por serem recomendações de um comité científico da EMA, são relevantes para acompanhamento regulamentar em Portugal e para preparação de eventual avaliação de introdução hospitalar, atualização de formulário ou análise de impacto assistencial.

O que importa rever nos casos locais

- Rever o resumo do CHMP de junho e sinalizar à Comissão de Farmácia e Terapêutica novas autorizações ou extensões de indicação relevantes para o hospital.
- Preparar a avaliação de introdução dos medicamentos com potencial impacto assistencial.

Grau de prioridade local: Moderado

OUTRAS NOVIDADES RELEVANTES

Qualidade, Fornecimento e Mercado do Medicamento

Recalls de medicamentos nos EUA (Corlanor/Sensipar, clortalidona e duloxetina). Foram reportados vários recalls nos EUA com base em relatórios da FDA: a Amgen retirou mais de 944 000 frascos de Corlanor (ivabradina) e Sensipar (cinacalcet) por presença de substância estranha e desvios de CGMP, com lotes e NDC identificados; a Inventia Healthcare retirou mais de 11 000 frascos de clortalidona 25 mg por falha nas especificações de dissolução, incluindo os lotes RISA24001 e ISB24002; e a Towa Pharmaceutical, com distribuição pela Breckenridge Pharmaceutical, retirou duloxetina por presença de N-nitroso-duloxetina acima do limite recomendado pela FDA, num recall de Classe II.

Relevância para a farmácia hospitalar: estes recalls têm origem nos EUA e não são comunicados da EMA, pelo que não há aplicação direta confirmada em Portugal. Retêm-se como contexto de vigilância da qualidade — nitrosaminas, dissolução, contaminação — e de monitorização de sinais de mercado.

Fontes: EatingWell [N5]; Health.com [N20]; Good Morning America [N21] — [eatingwell.com](https://www.eatingwell.com)

Critical Medicines Act da UE. Numa análise publicada no período, foi destacado que, em 11 de maio de 2026, o Conselho da UE e o Parlamento Europeu chegaram a acordo sobre medidas destinadas a reforçar o abastecimento de medicamentos. Segundo a fonte, o Critical Medicines Act aguardava aprovação formal e inclui medidas para incentivar o fabrico na UE e para que a contratação pública de medicamentos críticos considere a diversidade da cadeia de abastecimento, e não apenas o preço.

Relevância para a farmácia hospitalar: se formalmente aprovado e implementado, poderá influenciar as políticas de aquisição e a gestão de stocks críticos, sendo relevante para o planeamento antecipado de faltas.

Fonte: The Pharmaceutical Journal [N24] — [pharmaceutical-journal.com](https://www.pharmaceutical-journal.com)

Reações Adversas e Sinais de Segurança

Encefalopatia de Wernicke após semaglutida para obesidade. Uma revisão sistemática PRISMA de relatos de caso identificou seis casos de encefalopatia de Wernicke após tratamento com semaglutida para obesidade. Todos os doentes apresentaram sintomas gastrointestinais prolongados e perda ponderal substancial antes da deterioração neurológica; as manifestações comuns incluíram alteração do estado mental e anomalias oculomotoras. A fonte refere desfechos desfavoráveis em vários casos, incluindo progressão para síndrome de Korsakoff ou morte, e conclui que os clínicos devem manter vigilância para deficiência de tiamina em doentes com intolerância gastrointestinal persistente ou perda ponderal rápida durante o tratamento com agonistas do GLP-1, sendo essencial a administração precoce de tiamina parentérica quando clinicamente indicada.

Relevância para a farmácia hospitalar: relevante para a reconciliação terapêutica, para a avaliação de sintomas neurológicos em doentes expostos a semaglutida e para a comunicação com as equipas de urgência, medicina interna, endocrinologia e nutrição.

Fonte: PubMed [P4] – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42399213

Hematotoxicidade após terapêutica com CAR-T (ICAHT). A análise da base FAERS, via OpenVigil 2.1, identificou sinais de desproporcionalidade fortes e concordantes de immune effector cell-associated hematotoxicity (ICAHT) em cinco de sete produtos CAR-T atualmente aprovados pela FDA, com maior número de casos para o axicabtagene ciloleucel.

Relevância para a farmácia hospitalar: relevante para centros que administram terapias celulares; apoia a monitorização hematológica pós-infusão e a investigação de citopenias inexplicadas, de acordo com os protocolos clínicos locais.

Fonte: PubMed [P14] – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42381271

ARTIGO CIENTÍFICO EM DESTAQUE — DEEP DIVE

Título traduzido: «Utilização de dados de farmacovigilância para detecção de sinais de interações medicamentosas com a rosuvastatina» [P11]

PubMed: pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42396714

Objetivo do estudo: Investigar se o uso concomitante de rosuvastatina com fármacos identificados como inibidores in vitro do BCRP se associa a um maior número de notificações de rabdomiólise em dados de farmacovigilância.

Tipo de estudo: Estudo de detecção de sinais / análise de desproporcionalidade em farmacovigilância.

População / base de dados: Notificações do FAERS (FDA Adverse Event Reporting System) relativas a doentes a utilizar rosuvastatina, no período 2013–2023.

Principais resultados: Foram identificadas 9777 notificações relacionadas com rosuvastatina, incluindo 815 de rabdomiólise. Dos 71 inibidores do BCRP considerados, 19 tinham notificações suficientes para análise. Obtiveram-se RORs significativamente aumentados para o febuxostate (ROR 2,47; IC 95% 1,38–4,43) e o ticagrelor (ROR 4,15; IC 95% 3,32–5,20), bem como para a amiodarona, o erlotinib e a rifampicina.

Limitações: Como a análise se baseia em notificações do FAERS e em RORs, os resultados devem ser interpretados como sinais de reporte/desproporcionalidade. Não quantificam incidência nem risco absoluto e não estabelecem, por si só, causalidade individual sem avaliação clínica adicional.

Força da evidência para decisão clínica: Sinal de farmacovigilância relevante, gerador de hipótese. A fonte apoia interações já conhecidas com o febuxostate e o ticagrelor e sugere que outros inibidores do BCRP podem aumentar o risco de rabdomiólise induzida por rosuvastatina.

Porque é relevante para farmacêuticos hospitalares: A farmácia hospitalar pode contribuir para a detecção de associações entre a rosuvastatina e medicamentos identificados como inibidores do BCRP, bem como para a comunicação de sinais de toxicidade muscular/rabdomiólise às equipas clínicas.

Possíveis implicações: Reforço da revisão de terapêuticas concomitantes e da vigilância de toxicidade muscular/rabdomiólise em doentes que associem rosuvastatina a inibidores do BCRP, com utilidade potencial para configurar alertas de interação nos sistemas de prescrição.

CHECKLIST PRÁTICA PARA OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

Ações sugeridas para o período, com indicação das áreas envolvidas e da fonte correspondente.

- Preparar nota para a Comissão de Farmácia e Terapêutica sobre a conclusão do PRAC relativa ao valproato, clarificando que a evidência é inconsistente e que a causalidade é incerta, e acompanhar a atualização da informação do medicamento — Serviços Farmacêuticos / CFT — [N43]
- Informar as equipas clínicas e de urgência de que os IECA devem ser interrompidos imediatamente perante suspeita de angioedema e de que o angioedema mediado por bradicinina pode não responder ao tratamento padrão da anafilaxia, incluindo adrenalina — Serviços Farmacêuticos / Urgência / Medicina Interna / Cardiologia — [N8]
- Rever o resumo do CHMP de junho e sinalizar novas autorizações ou extensões de indicação relevantes para o hospital — Serviços Farmacêuticos / CFT — [N25]
- Sensibilizar as equipas para considerar deficiência de tiamina/encefalopatia de Wernicke em doentes sob semaglutida com sintomas gastrointestinais persistentes ou perda ponderal rápida — Serviços Farmacêuticos / Urgência / Medicina Interna / Endocrinologia / Nutrição — [P4]
- Rever/configurar alertas de interação rosuvastatina + inibidores do BCRP, priorizando o febuxostate e o ticagrelor e considerando também a amiodarona, o erlotinib e a rifampicina quando aplicável, e reforçar a vigilância de toxicidade muscular/rabdomiólise — Serviços Farmacêuticos / Sistemas de Informação / equipa clínica — [P11]

FONTES UTILIZADAS

14 fontes selecionadas, 10 citadas.

- [N43] Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 8-11 June 2026 — European Medicines Agency (EMA) — ema.europa.eu
- [N8] MHRA issues drug safety warning over ACE inhibitor side effect — The Pharmaceutical Journal — pharmaceutical-journal.com
- [N25] Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 22-25 June 2026 — European Medicines Agency (EMA) — ema.europa.eu
- [N5] FDA Recalls Heart and Kidney Medications Nationwide — EatingWell — eatingwell.com
- [N20] FDA Announces Recall of Common Blood Pressure Medication — Health.com — health.com
- [N21] Antidepressant recalled due to presence of potentially cancer-causing impurity — Good Morning America — goodmorningamerica.com
- [N24] The Critical Medicines Act: can the UK manage supply problems with the EU's 'safety belt'? — The Pharmaceutical Journal — pharmaceutical-journal.com
- [P4] Wernicke's Encephalopathy Following Semaglutide Treatment for Obesity: A Systematic PRISMA Review of Case-Based Evidence — PubMed — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42399213
- [P14] Immune effector cell-associated hematotoxicity following CAR-T cell therapies: insights from a large national database — PubMed — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42381271
- [P11] Using Pharmacovigilance Data for Signal Detection of Drug Interactions for Rosuvastatin — PubMed — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42396714

NOTA METODOLÓGICA

Este relatório resulta da análise integrada de duas fontes de informação:

- (1) recomendações e conclusões de sinais de segurança do PRAC (reunião de 8-11 de junho de 2026) e recomendações do CHMP (reunião de 22-25 de junho de 2026);
- (2) notícias de âmbito regulamentar e de imprensa especializada, bem como publicações científicas indexadas, referentes aos últimos 30 dias.

O período de referência corresponde aos últimos 30 dias e os destinatários são os farmacêuticos hospitalares em Portugal. Os alertas de agências fora da União Europeia (MHRA, FDA) são apresentados como contexto de vigilância, sem aplicação regulamentar direta confirmada em Portugal.

Relatório produzido pela PDH para a produção de informação relevante em farmacovigilância.